أمر قانوني رقم 2005 - 006 صادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005[19] ينشئ نظاما للتأمين الصحي المعدل بـ:

- **القانون رقم 2010 - 018 صادر بتاريخ 03 فبراير 2010[20].**

[19] - الجريدة الرسمية عدد 1117 بتاريخ:30 ابريل 2006.
[20] - الجريدة الرسمية عدد 1212 بتاريخ 30 مارس 2010.

المادة الأولى: ينظم نظام إلزامي للتأمين الصحي الأساسي يعتمد على مبدأ المشاركة و مبدأ التكافل التحمل المخاطر، لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أسفله و من له الحق من أقربائهم.

المادة 2: يطبق نظام التأمين الصحي الأساسي على مجموعات المؤمنين الثلاث التالية:

1- البرلمانيون و موظفو ووكلاء الدولة (المجموعة I)

2- أفراد القوات المسلحة في وضعية المباشرة (المجموعة II)

3- المستفيدون من معاشات التقاعد البرلمانية و المستفيدون من معاشات التقاعد المدنية والعسكرية (المجموعة III)، المتفرعة عن المتفرعة عن المجموعة (I وII).

فقرة 2 :(جديدة):(قانون رقم: 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): كما يطبق على مجموعات المؤمنين التالية:

- عمال المؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس المال العمومي و كذلك عمال شخصيات القانون العام الاعتبارية (المجموعة vi)؛
- المستفيدين من معاشات التقاعد من المؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس المال العمومي وشخصيات القانون العام الاعتبارية (المجموعة v)؛
- بناء على طلبهم أعضاء الأسلاك المهنية المعترف بها شرعا (المجموعة VI).

الباب الأول حقل تطبيق هذا النظام

الفصل الأول المستفيدون

المادة 3 (جديدة):(قانون رقم: 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): يستفيد من نظام التأمين الصحي المذكور في هذا الأمر القانوني كل من:

- المؤمن الاجتماعي؛
- زوج المؤمن؛
- أطفال المؤمن الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة؛

- أطفال المؤمن بدون حد في العمر إذا كانوا معاقين إعاقة تمنعهم من ممارسة عمل معوض عنه؛
- الوالدين المباشرين للمؤمن بناء على طلبه.

و تحدد شروط و وعاء المساهمة بواسطة مرسوم.

الفصل الثاني: الخدمات المضمونة

المادة 4: يضمن نظام التأمين الصحي الأساسي للأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، تغطية المخاطر و مصاريف العلاج المتعلقة بالمرض و الحوادث و الأمومة وإعادة التأهيل الجسمي و الوظيفي.

أما المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل و الأمراض المهنية فتظل منظمة بالتشريعات و التنظيمات الخاصة بها.

يعطي نظام التأمين الصحي الإلزامي الحق للمستفيد في أن تسدد له أو تتحمل عنه مباشرة بشروط وطبقا الإجراءات ستحدد بمرسوم، مصاريف العلاجات الوقائية و العلاجية و إعادة التأهيل التي تتطلبها حالته الصحية والمتعلقة بالخدمات التالية:

- العلاجات الإسعافية الوقائية والاستشارات والعلاج و الخدمات الملحقة.
- العلاجات الاستشفائية، الاستشارات والجراحة العلاجات غير الجراحية و الأدوية طيلة الإقامة في المستشفى الأدوية المجدولة.
- الرفع الطبي لتلقي علاجات ضرورية واردة في القائمة وتحدد بمقرر مشترك من وزير المالية و الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة التخصصات والأعمال الطبية و شبه الطبية و الأدوية و الأجهزة و مصاريف النقل الصحي التي يغطيها نظام التأمين الصحي الأساسي.

المادة 5 (جديدة): (قانون رقم 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): لا تدخل في حقل الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الصحي الأساسي، العمليات

الجراحية التجميلية و التشكيلية (باستثناء عمليات جراحة الترميم و تقويم اعوجاج أعضاء الفك و الوجه التي تتطلبها حالة المريض الصحية)، ولا تركيب الأسنان أو تقويمها و لا التداوي بالمياه الحارة أو بحمامات البحر و لا الوخز بالإبر و لا علاج الداء بالداء - المعالجة المثلية - و لا العلاج المحلي للأعضاء و لا العلاج بالأعشاب و بصفة عامة كل الخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الرفيق أو التقليدي.

الباب الثاني: تسيير نظام التأمين الصحي و الأساسي

المادة 6: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يطلق عليها فيما يلي هيئة التسيير، تكلف بتسيير نظام التأمين الصحي الأساسي الوارد في هذا الأمر القانوني ويحدد التنظيم الإداري والمالي لهذه الهيئة و طرف تسييرها بموجب مرسوم و يتم تحديده عند الاقتضاء استثناء من الترتيبات التشريعية و التنظيمية المطبقة على المؤسسة بحيث تضمن بصفة أفضل مساهمة مختلف المستفيدين منها ولهذا الغرض يمكن أن تتعلق الاستثناءات على الخصوص بما يلي:

- التنظيم الإداري؛
- نظام الأساسي للعمال؛
- نظام الصفقات والعقود؛
- نظام المحاسبة.

المادة 7: تتمثل مهمة هيئة التسيير في:

- توفير ظروف تتيح توازنا ماليا لنظام التأمين الصحي الأساسي؛
- تحسين الخدمات والتغطية الصحية للمؤمنين؛
- المساهمة في الرفع من مستوى الخدمات في القطاع الصحي.

رقابة منح الموارد لمقدمي الخدمات، وفي هذا الإطار تعمل هيئة التسيير على:

- ترشيد كلفة المصاريف الصحية عن طريق وضع تعريفات واقعية و حوافز الاستغلال الوسائل بصفة رشيدة.

- تشجيع روح التضامن بين المؤمنين؛
- تحسين تقديرات الموارد الضرورية؛
- المساهمة في بروز قطاع طبي ناجح وقادر على المنافسة.

الباب الثالث: شروط و طرق التسديد والتكفل

الفصل الأول: شروط التسديد و التكفل

المادة 8: يضمن نظام التأمين الصحي الوارد في هذا الأمر القانوني التسديد و التحمل المباشر لكل أو جزء مصاريف العلاج من طرف هيئة التسيير على أن يحتمل المؤمن الجزء الأخر.

و يحتفظ هذا الأخير بحقه في الانتساب لنظام تأميني صحي تكميلي ليتحمل عنه المصاريف المتبقية إلا أنه في حالة مرض خطير أو معيق يتطلب علاجات طويلة المدة أو في حالة تلقي علاجات باهظة الثمن فإن الجزء الباقي على المؤمن يكون إعفاء كلي أو جزئي.

تحدد بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالوظيفية العمومية و الوزير المكلف بالدفاع الوطني بالأمراض التي تعطي حق الإعفاء و الظروف التي يتم في ذلك الإعفاء.

المادة 9: يتم تسديد أو تحمل المصاريف التي صرفها المستفيد من طرف هيئة التسيير حسب ما يلي:

- حسب العمل العلاجي المقام على أساس اللائحة التصنيفية للأعمال المهنية المحددة من طرف الوزير المكلف بالصحة.
- على أساس مبلغ جزافي، حسب المرض أو حسب مجموعة الأمراض المتشابهة؛
- على شكل مبلغ إجمالي أو تسديد مسبق؛
- على أساس ضريبة الدخل حسب كل شخص و في جميع الأحوال فإن فاتورة

الخدمات العلاجية.

يجب أن تعد طبقا للقواعد المحددة بمقرر من وزيري المالية والصحة بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التسيير.

المادة 10: تحدد التعريفة الوطنية التي تعتبر مرجعا لتسديد أو نحمل الخدمات العلاجية المضمونة أو الأودية حسب ما يلي:

- عن طريق مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة، عند الاقتضاء؛
- عن طريق التعاقد المتفاوض عليه: تطبيقا للفصل الثاني من هذا الباب و بخصوص الآلات و التجهيزات الطبية فإن التعريفة الوطنية التي تعتبر مرجعا، يصادق عليها الوزيران المكلفان بالمالية و الصحة، بناء على اقتراح من هيئة التسيير.

المادة 11: الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الصحي الأساسي لا يمكن تسديدها ولا تحملها إلا إذا كانت العلاجات قد أمر بها أو نفذت على التراب الوطني المصالح المستفيدين من هيئة التسيير يمكن قبولها في نطاق حدود يبينها هذا الأمر القانوني والنصوص المطبقة له، وذلك في حالة ما إذا أصيب المستفيد بمرض مفاجئ و هو إذ ذاك مقيم في الخارج.

و الخدمات المؤداة خارج التراب الوطني يمكن كذلك قبولها في نطاق شروط يبينها هذا الأمر القانوني و النصوص المطبقة له، إذا كان المستفيد موضع رفع صحي للخارج حيث تعذر تلقيه للعلاجات المناسبة لحالته الصحية في موريتانيا.

- و في هذه الحالة الأخيرة، فإن التسديد و التحمل مشروطان بالموافقة المسبقة لجهاز التأمين، حسب إجراءات ستحدد بنص تنظيمي.

المادة 12: يتمتع المؤمن بحق اختيار الطبيب الممارس، و المؤسسة الصحية و الصيدلاني، و عند الاقتضاء، العامل شبه الطبي، وموارد الآلات و التجهيزات الطبية التي أمر بها،

مع احترام إجراءات التنظيم التي يحددها هذا الأمر القانوني و النصوص المطبقة له.

المادة 13: تحدد بنص تنظيمي:

- إجراءات إيداع الوثائق المبررة للمصاريف التي أنفقها المؤمن و أجال إيداعها.
- الأجل الأقصى لتسديد المصاريف الطبية للمؤمن من طرف الهيئة المسيرة وكذلك الأجل الأقصى الحصول على بطاقات التكفل.
- الأجل الأقصى للتسديد لصالح مقدمي الخدمات في حالة تدخل من طرف ثالث في التسديد.

المادة 14: إن عدم احترام المؤمن للإجراءات والتنظيمات التي تمنحه حق التسديد لا يلغي حقه في هذا التسديد إذا ظهر أن ذلك راجع لأسباب خارجة عن إرادة المعنى و خصوصا إذا كان ذلك راجعا إلى حالته الصحية.

الفصل الثاني: إجراءات التقاعد

المادة 15 : العلاقات بين مقدمي الخدمات العلاجية وهيئة التسيير تنظمها الاتفاقيات المبرمة بين هذه الهيئة و ممثلي مقدمي الخدمات وتحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص الميادين التالية:

- واجبات الأطراف المتعاقدة؛
- التعريفة المرجعية للخدمات العلاجية؛
- وسائل التحكم في النفقات الصحية؛
- وسائل ضمان جودة الخدمات؛
- إجراءات و طرق التسديد لصالح مقدمي الخدمات العلاجية.
- آليات تسوية الخلافات.

المادة 16: الاتفاقيات المباشرة إليها في المادة السابقة يصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالصحة بموجب مقرر .

و في حالة عدم الاتفاق على مقتضيات الاتفاقيات فإن الوزير يعلن تلقائيا سريان الاتفاقية السابقة إذا كانت موجودة،

و إلا فإنه يصدر تنظيما تعريفيا مؤقتا. نصوص الاتفاقيات و مقررات المصادقة في الجريدة الرسمية.

المادة 17: يجوز لوزير الصحة بناء على طلب من هيئة التسيير ودون المساس بالعقوبات النظامية أن يضع أحد مقدمي خدمات العجلات الطبية خارج الاتفاقية وذلك في حالة عدم احترام هذا الأخير أو انتهاكه لبنود الاتفاقية، و بعد أن يسمح له بتقديم ملاحظاته، و يعلن الوضع خارج الاتفاقية لفترة محددة. وتحدد بنص تنظيمي إجراءات الوضع خارج الاتفاقية و إجراءات الرجوع إليها.

المادة 18 : يتم تحمل مصاريف العلاجات المضمونة طبقا لهذا الأمر القانوني، وأيا كان مقدم الخدمات، متعاقد أم لا، على أساس التعريفية الوطنية المرجعية التي تحددها الاتفاقية

الفصل الثالث: الرقابة الطبية

المادة 19: يجب على هيئة التسيير إقامة رقابة طبية على مقدمي الخدمات العلاجية تهدف أساس إلى التأكد من تطابق الوصفات الطبية مع الخدمات الطبية الممنوحة ومن سلامة الخدمات على المستوى الفني و الطبي و إلى ملاحظة التجاوزات و الغش في ميدان الوصفات و العلاجات و إصدار الفواتير عند الاقتضاء.

و يعهد بالرقابة الطبية إلى أطباء و صيدلانيين استشاريين وغيرهم من المهنيين المعتمدين من طرف هيئة التسيير، و يكلفون أساس بالمهام التالية:

- متابعة و رقابة نوعية الخدمات المقدمة من طرف مقدم الخدمات العلاجية و ملاحظة ملاءمتها مع الحالة الصحية للمستفيد؛
- التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف ضمان تكفل ملائم بالخدمات العلاجية

المنوحة للمؤمنين الاجتماعيين و المستحقين؛

- متابعة تطورات المصاريف الصحية للمؤمنين . إصدار آراء حول تحمل مصاريف الخدمات العلاجية التي تتطلب موافقة مسبقة.

و يحدد مرسوم طرق إجراءات ممارسة هذه المهام و الأطباء الممارسون الذين عهد إليهم بالرقابة الطبية لا يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الوظيفية و وظيفة المعالج بخصوص الملف موضع الرقابة.

المادة 20: مع مراعاة المبادئ المتعلقة بأخلاقيات المهنة و التشريعات المعمول بها، يجوز للأطباء المستشارين خلال ممارسة مهامهم :

- أن يستدعوا المستفيدين من الخدمات و يخضعوه للتشخيص و وإجراءات خبرة، عند الاقتضاء.
- - وإجراءات خبرة، عند الاقتضاء.
- أن يحصلوا على جميع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيد.
- الاطلاع على الملف الطبي للمستفيد. طلب إيضاحات من مقدمي الخدمات و العلاجات حول الحالة الصحية للمستفيد.
- زيارة البني الصحية لملاحظة ظروف التكفل المستفيدين.

المادة 21: يجب على الأطباء المباشرين و مديري العبادات و المؤسسات الصحية أيا كان مركزهم القانوني أن يسمحوا للطبيب المباشر المكلف بالرقابة الطبية بحرية التنقل و التدخل في أماكن الاستشفاء و أن يضعوا تحت تصرفه كافة الوثائق الضرورية لإنجاز مهمة الرقابة.

و يمكن للأطباء المعالجين أن يحضروا الفحوص الطبية، بناء على طلب من المستفيد أو من الطبيب المكلف بالرقابة.

المادة 22: لا يمكن لأي مستفيد من الخدمات الواردة في هذا الأمر القانوني أن يتملص من الرقابة الطبية وفي حالة امتناعه فإن تسديد المصاريف المنفقة للعلاجات

الطبية يعلق طيلة الفترة التي تظل فيها الرقابة غير ممكنة.

المادة 23: في حالة الرقابة الطبية، يبلغ القرار الذي تتخذه هيئة التسيير على أمر هذه الرقابة إلى المعني.

و لهذا الأخير الحق في الاعتراض على هذا القرار أمام الوزير المكلف بالصحة و الذي يعين طبيبا خبيرا لإجراء فحص حديد. و تعتبر النتائج التي يقدمها هذا الطبيب الخبير ملزمة للطرفين.

المادة 24: يحدد مرسوم الظروف و الإجراءات والآجال التي تمارس فيها الرقابة الطبية.

الباب الرابع: تسيير و رقابة الخدمات هيئة التسيير

الفصل الأول: ظروف منشئ الحق في الخدمات والاحتفاظ به وتعليقه أو إلغائه.

المادة 25: يتوقف الحق في الحصول على الخدمات، على التسديد المسبق للمساهمات. و يحق لهيئة التسيير أن تعلق منح الخدمات إذا كان هذا التسديد لم يقع بالفعل. إلا أنه في حالة ما إذا كان المؤمن المعني، أو من له الحق من أقاربه مصابا بمرض طويل المدة يترتب عنه عجز و تتطلب معالجته مصاريف جد باهظة، فإن الهيئة المسيرة ملزمة بمتابعة الخدمات لهؤلاء الأشخاص طالبة من الدولة باعتبارها المشغل، أن تصحح وضعها اتجاه المصالح المكلفة بالتحصيل.

فقرة 2 :(جديدة):(قانون رقم: 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): إلا أنه في حالة ما إذا كان المؤمن المعني، أو من له الحق من ذويه مصابا بمرض طويل المدة يترتب عنه عجز أو تتطلب معالجته مصاريف باهظة، فإن الهيئة المسيرة ملزمة بمتابعة الخدمات لهؤلاء الأشخاص طالبة من رب العمل أو السلك المعني، أن يصحح و ضعه اتجاه المصالح المكلفة بالتحصيل.

المادة 26: تلتزم هيئة التسيير بالتحقيق و الرقابة حول قابلية الأشخاص التابعين لنظام التأمين الصحي الأساسي و أن تراقب بصفة دائمة تأسيس الحق في الحصول على الخدمات أو إلغائها.

المادة 27: الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من نظام التأمين الذي تسييره هيئة التسيير باعتبارهم مؤمنين أو مستحقين، يحتفظون بالاستفادة من الخدمات لمدة ستة أشهر على الأكثر اعتبارا من تاريخ عدم توفر الشروط. إلا أنه إذا توفرت خلال هذه الفترة في المعني نفسه أو أحد المستحقين شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الصحي أو للمساعدة الطبية فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يصبح لاغيا.

المادة 28: يستفيد ورثة المؤمن من المتوفى الذين لا يتبعون لأي نظام تأمين صحي آخر من خدمات نظام هيئة التسيير لمدة سنتين.

الفصل الثاني: قواعد الانتساب والتسجيل و التسيير

المادة 29: للاستفادة من الخدمات الممنوحة في إطار نظام التأمين الصحي الأساسي، فإنه يجب على المؤمن أو من له الحق في التأمين، أن ينتسبوا وأن يسجلوا لدى هيئة التسيير.

المادة 30: يحدد مرسوم طرق انتساب وتسجيل التابعين لأنظمة الصندوق.

الفصل الثالث: نظام التعارض

المادة 31: لا يجوز لهيئة التسيير أن تجتمع بين وظيفة مسير نظام التأمين الصحي ووظيفة تسيير المؤسسات التي تقوم بخدمات التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو التي تقوم بخدمات التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو التي تقوم بالتمويل بالأدوية أو المعدات والتجهيزات الطبية.

إلا أنه يجوز لهيئة التسيير وفي ظروف يحددها تشريع خاص أن تساهم في العمل الصحي للدولة طبقا للسياسة الوطنية في ميدان الصحة.

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالنظام المالي والرقابة الفنية

الفصل الأول: الموارد المالية

المادة 32: تتشكل موارد نظام التأمين الصحي الوارد في هذا الأمر القانوني مما يلي:

- المساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر القانوني والزيادات والغرامات وعقوبات التأخير المطبقة عليها عند الاقتضاء؛
- الأرباح المالية؛
- فوائد الأموال المودعة و ارتفاع قيم الأصول؛
- كل مورد آخر يمنح لنظام التأمين الصحي بموجب تشريع أو تنظيم خاص؛
- الإعلانات و الهبات و الهدايا.

المادة 33 (جديدة): (قانون رقم: 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): يحدد أساس المساهمة حسب نظام الأجور المطبق على الأشخاص التابعين لهذا النظام أو حسب الدخل.

فبالنسبة للمجموعات: 1، II و IV تحدد المساهمة على أساس مجموع الأجور المسددة بما في ذلك العلاوات و الامتيازات.

و بالنسبة للمجموعات: III وV تحدد المساهمة على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات برسم التقاعد و الشيخوخة و الإعاقة، المسددة للمستحقين برسم أنظمة التقاعد باستثناء نظام التقاعد التكميلي إذا كان موجودا.

و بالنسبة للمجموعة V1: تحدد المساهمة على أساس دخل مهني سيتم تحديده مبلغه بموجب مرسوم.

المادة 34: تحدد نسبة المساهمة بموجب مرسوم. و يجب أن تحدد هذه النسبة بصفة تضمن التوازن المالي للعمليات و يجب الخاصة بكل واحد من المجموعات التابعة لهذا النظام أخذ بعين الاعتبار للمبالغ الخاضعة للمساهمة، و مصاريف الخدمات و كلفة التسيير الإداري و كلفة الاقتطاع بالنسبة الكل مجموعة من المجموعات الثلاث الخاضعة للنظام، و لتغطية الاحتياطات الواردة في المادة 38 أسفله.

و في حالة ما إذا اقتضت ضروريات التوازن المالي النظام التأمين الأساسي، فإن المساهمة يمكن أن تطابق بين المجموعات له و توزع بين المؤمنين و الدولة وفي حالة اختلال، يصحح معدل المساهمة بمرسوم.

و تلتزم هيئة التسيير بتطبيق خطة محاسبة خاصة، مع احترام التشريعات و القوانين المعمول بها، و تكون المحاسبة منفصلة بالنسبة للعمليات التابعة لكل مجموعة من المؤمنين.

فقرة 2 :(جديدة):(قانون رقم: 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): و يجب أن تحدد هذه النسبة. بصفة تضمن التوازن المالي للعمليات الخاصة بكل واحد من المجموعات الست التابعة لهذا النظام أخذا بعين الاعتبار للمبالغ الخاضعة للمساهمة، و مصاريف الخدمات و كلفة التسيير الإداري و كلفة الاقتطاع بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات الست الخاضعة للنظام، و لتغطية الاحتياطات الواردة في المادة 36 أسفله.

فقرة 3 : (جديدة):(قانون رقم: 2010 - 018 بتاريخ 03 فبراير 2010): و في حالة ما إذا اقتضت ضرورة التوازن المالي لنظام التأمين الأساسي، فإن المساهمة يمكن أن تطابق بين المجموعات التابعة له و توزع بين المؤمنين و الدولة و أرباب العمل و الأسلاك المعيين.

المادة 35: لا يجوز لهيئة التسيير أن تشغل الموارد المخصصة لنظام التأمين الصحي الأساسي لغايات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الأمر القانوني.

المادة 36: يجب على هيئة التسيير أن تكون احتياطيا أمنيا و احتياطيا لتغطية مصاريف

خدمات العلاج المتبقية التي يضمنها هذا الأمر القانوني. ويحدد مرسوم طرق تكوين هذين الاحتياطيين وتسييرهما وتقديمهما.

و تودع المبالغ الممثلة لهذين الاحتياطيين و كذلك الفائض المحتمل من موارد نظام هيئة التسيير عن نفقاته، لدى الهيئات التي تعينها هذه الأخيرة لذلك و مقابل فائدة معلومة.

الفصل الثاني: الرقابة الفنية على هيئة التسيير

المادة 37: دون المساس بالرقابة التي تمارسها محكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية تخضع هيئة التسيير للرقابة الفنية للدولة وتهدف هذه الرقابة إلى السهر على احترام أحكام هذا: الأمر القانوني و النصوص المطبقة له، وتجري هذه الرقابة ميدانيا وعلى الوثائق.

ولهذا الغرض يلزم الصندوق بأن يقدم إلى الإدارة جميع الجرود والتقارير والجداول والوثائق التي من شأنها أن تسمح برقابة الوضعية المالية، وتسوية الملفات وتكوين و تقديم الاحتياطات، و تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات العلاجية.

المادة 38: تتم. الرقابة الفنية ميدانيا من طرف الموظفين المنتدبين لذلك من قبل الإدارة.

المادة 39: إذا تضمن تقرير الرقابة على الوثائق وميدانيا بعض الملاحظات فإنه يبلغ هيئة التسيير التي تملك أجل ثلاثين يوما لتقديم إيضاحاتها كتابيا، وعند الاقتضاء، للإبلاغ عن الإجراءات التي تنوي القيام بها لتصحيح الوضعية

الباب السادس النزاعات : الطعون - العقوبات - الاستبدال

الفصل الأول: النزاعات - الطعون -العقوبات

المادة 40: يجب أن يقدم الطعن ضد قرار الرفض المتعلق بطلب تسديد خدمات هيئة التسيير أو باستعادة مساهمة حصلت بطريقة غير شرعية إلى هيئة التسيير تلافيا لفقدان الحق، وفي أجل سنة اعتبارا من تاريخ إبلاغ القرار المطعون فيه إلى مقدم الطلب.

يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف إلى خمسة ملايين أوقية:

- كل من يحصل على خدمات لا يستحقها أو يسهل الحصول عليها أو يحاول ذلك عن طريق الغش أو تزوير التصريحات؛
- كل من يتعاون مع المستفيدين من أحكام هذا الأمر القانوني للحصول على خدمات غير مستحقة؛
- كل من يوجه المستفيدين من أحكام هذا الأمر القانوني إلى للحصول على خدمات غير مستحقة؛
- كل من يوجه المستفيدين من أحكام هذا الأمر القانوني إلى مؤسسات صحية، عن طريق القهر أو التهديد أو التعسف في الاستعمال السلطة أو الإغراءات المادية أو من حاول القيام بذلك؛
- كل مقدم خدمات علاجية يطلب على أساس أحكام هذا الأمر القانوني أجرا على أعمال مهنية لم يقم بها أو إيرادات لم يسلمها أو ارتكب الغش أو تزويد التصريحات.

و يتضاعف مبلغ هذه العقوبة في حالة العودة و العقوبات الواردة في هذا الأمر القانوني لا تحول دون تطبيق عقوبات جنائية أكثر صرامة و لا عقوبات إدارية تنص عليها التشريعات المعمول بها.

وتحتفظ هيئة التسيير بحقها في طلب المخالف بتسديد التعويضات والفوائد التي يجب أن لا تقل عن المبالغ المحصول عليها بصفة غير شرعية.

الفصل الثاني: الاستبدال - الدعاوي في المسؤولية - البطلان

المادة 41: تحل هيئة التسيير محل الشخص المستفيد من الخدمات العلاجية الدعوى التي يقيمها ضد الغير المسؤول عن الأضرار في حدود الخدمات الممنوحة للمتضرر.

و في حالة دعاوى مقامة ضد الغير المسؤول فإنه يجب على المتضرر أو من له الحق أن

يبلغ هيئة التسيير للتدخل طبقا للتشريع المعمول به،

و كل تسوية ودية تقع بين الشخص و الغير المسؤول فإنها غير ملزمة لهيئة التسيير إلا إذا دعيت إلى المشاركة فيها برسالة مضمونة و لا تعتبر هذه التسوية نهائية إلا بعد استكمال ستين يوما اعتبارا من إرسال هذه الرسالة.

وفي حالة عدم احترام أحكام الفقرتين السابقتين يجوز لهيئة التسيير أن ترجع على المستفيد الذي حصل على تعويض من الغير المسؤول ليسدد لها المبالغ التي استفاد منها في حدود ما تم صرفه بالفعل.

المادة 42: إذا قام المتضرر أو من له الحق بدعوى تعويض أمام القضاء ضد الغير المسؤول، بسبب شرر ألحقه بهم فإنه يجب عليهم أن يبينوا في جميع مراحل الدعوى أن المتضرر مستفيد من نظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا الأمر القانوني.

و في حالة عدم تسديد المتضرر أو من له الحق للمبالغ غير المستحقة فإنه يمكن طلب إلغاء الحكم في الأصل من طرف النيابة العامة أو من طرف النيابة الجهاز المسير و ذلك خلال أربعة أعوام، اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نائيا.

المادة 43: يعتبر لاغيا أي اتفاق يخالف أحكام هذا الأمر القانوني إن كل تنازل من طرف المستفيدين عن الحقوق أو الأعمال المعترف لهم بها بمقتضى هذا الأمر القانوني، غير ملزم لهيئة التسيير.

المادة 44 : تتقادم الدعاوى التي يمكن التي يمكن أن يقوم بها المستفيد و مقدم الخدمات العاجية ضد هيئة التسيير بمرور سنتين، اعتبارا من تاريخ منشئ الحق. و تتقادم الدعاوى التي يمكن أن تقوم بها هيئة التسيير ضد الأشخاص الذين منحت لهم برسم هذا النظام امتيازات غير مشروعة بمرور سنتين و يسري

الباب السابع: الترتيبات النهائية

المادة 45: تبين أحكام هذا الأمر القانوني بمرسوم عند الاقتضاء

المادة 46: تلغى كافة الترتيبات السابقة والمخالفة لهذا الأمر القانوني

المادة :47 ينشر الأمر القانوني الحالي في الجريدة الرسمية.